الألم البطني والنزف الهضمي

1 د. باسل شوربا

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

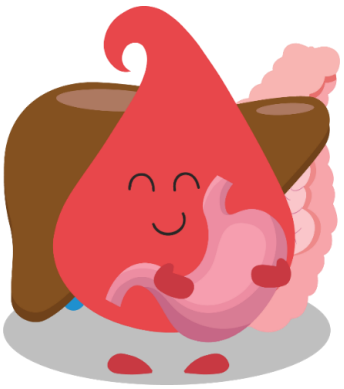
السلام عليكم

نقدم لكم المحاضرة الثانية من قسم المهارات الهضمية، التي سنُفصِّل فيها عن شكايات المريض الهضمي الأساسية (الألم والنزف الهضمي)

-نتمنى أن نكون قد وُفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل-

فهرس المحتويات

الفقرة	الصفحة
الألم البطني	2
النزف الهضمي	7



الألم البطني

- إن الألم البطني هو **أكثر أسباب** الاستشارات الهضمية.
- يقسم إلى:

1. الألم البطني الحاد Acute Abdominal Pain:

- للألم البطني الحاد تشخيصات تفريقيّة واسعة، ومجال شدة الألم كبير أيضاً ويمتدّ من الحالات الطفيفة البسيطة إلى الحالات المهددة للحياة.
- والطبيب الناجح هو الذي يستطيع الوصول إلى التشخيص **بسرعة**، وذلك عن طريق **تقسيم مسببات هذا الألم إلى تناذرات**.

2. الألم البطني المزمن Chronic Abdominal Pain:

- في معظم حالات الألم البطني المزمن عند **الشباب** يكون السبب **خلل وظيفي Functional Disorder**.
- أما في المرضى **الأكبر عمراً** الذين يشتكون من ألم بطني جديد ودائم، الأولويّة تكون لاستقصاء **وجود خباثة Malignancy**.

- يُقسم الألم إلى نوعين: **ألم حشوي Visceral** و**ألم جسمي Somatic**.

	الحشوي	الجسمي
المنشأ	التقلص الشديد للأعضاء أو تمددها	هياج أو التهاب البريتوان الجداري
النقل	عبر الألياف العصبيّة الذاتيّة	عبر الأعصاب الجسميّة (القطنية)
صفات الألم	غير واضح - قليل التوضّع (غير متمركز في مكان محدد)	حاد - متموضع بشكل جيّد - متواصل وغالباً مرتبط مع إيلام Tenderness

الألم الرجيع Referred pain: هو الألم الذي يتم الشعور به في موقع بعيد عن مصدر الألم الأصلي، غالباً بسبب وجود تعصيب مشترك بين المنطقتين.

مقاربة مريض ألم بطني

☑ جاء مريض يشتكي من ألم في بطنه، يُفيدنا معرفة **خصائص هذا الألم** في التوجُّه للتشخيص.

1. مكان الألم.

2. شكل الألم:

- غالباً نحدد شكل الألم بالأشكال التالية:

حارق	ثقل	نفخة	شد	قولنجي	طاعن (ناخز)	نابض

ما هو الألم القولنجي وما سببه؟ RBO Clinical

- الألم القولنجي هو تشنج مؤلم في حشا أجوف (أي لا نراه في الأعضاء الصماء كالكبد والبنكرياس).
- يتميّز بأنه يأتي **نوبي** وليس ثابت.[1]
- إنّ أي عائق في مسير الحركات الحوية في كل حشا اجوف (من المريء إلى الشرج بالإضافة إلى الطرق الصفراوية) سواء أكان ورم أو حصاة أو أي اضطرابات عصبية في هذه الحركات، فإنها تسبب تقلصات شديدة جداً ومؤلمة.

3. شدة الألم:

- **لا** يوجد معيار وصفي لتحديد شدّة الألم، وهي نسبية بين مريض و آخر.
- يُمكن اعتبار **قدرة الألم على إيقاظ المريض من النوم** أهم المقاييس لتحديد شدّة الألم.

4. انتشارات الألم.

5. زمن الألم:

- من المهم جداً سؤال المريض عن التفاصيل الزمنية المتعلقة بالعرض؛ **فالإسهال الحديث** عند رجل **بعمر 60** سنة هو **سرطان حتى يثبت العكس**، بينما **إسهال رافقه خلال 30 سنة** فهو حتماً **ليس بسرطان**.
- ندرس فيه:
  - **البدء:** مفاجئ أم تدريجي.
  - **الاستمرار:** من عدة دقائق إلى عدة ساعات (ثابت - متزايد - متناوب).
  - **التردد:** في اليوم بعد الطعام بشكل باكر أو متأخر -أيام انقطاعه- فترة الهجوم.

6. محرضات الألم.

7. مسكنات الألم.

8. الأعراض المرافقة.



EXTRA

[1] أما الألم في الأعضاء الصماء كالكبد فيكون مستمراً.

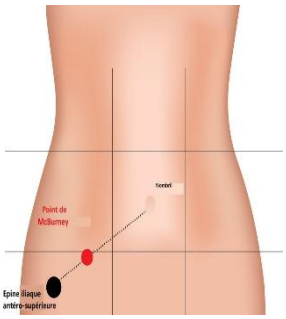
الفحص الفيزيائي - النقاط الألمية

علامة مورفي Murphy Sign:



- هي **النقطة الألمية للمرارة**.
- يأخذ المريض نفساً عميقاً، ويقوم الطبيب بالضغط على النقطة **في المراق الأيمن**.
- **إيجابية العلامة:** تكون إيجابيّة عند وجود ألم وتوقف للنفس في المراق الأيمن، فتدل على تناذر صفراوي.

علامة ماك بورني Mac Burney Sign:



- هي **النقطة الألمية للزائدة الدودية**.
- يتم فحصها بالضغط **في الحفرة الحرقفية اليمنى** عند **اتصال الثلث الوحشي بالثلثين الانسيين** من الخط الواصل بين السرة والشوك الحرقفي الأمامي العلوي.
- **إيجابية العلامة:** تكون الإيجابية بحدوث ألم عند الضغط.

التناذرات الهضمية

☑ تقسم إلى تناذرات قرحية، تناذرات صفراوية، وتناذرات كولونية.

↙ جدول يوضح أهم الفروق بين التناذرات الهضمية الثلاثة:

	التناذر القرحي	التناذر الصفراوي	التناذر الكولوني
مكان الألم	في الشرسوف	في الشرسوف والمراق الأيمن	متنقل بأنحاء البطن، أماكن تزوي الكولون
شكل الألم	تشنج - حارق	شد، ممزق، قولنجي	تشنج، قولنج، واخز، نفخة وحس ثقل
شدة الألم	شديد، يوقظ من النوم	شديد جداً، يوقظ من النوم	خفيف إلى متوسط الشدة، لا يوقظ المريض
الانتشار	غالباً لا يتنشر، أحياناً للظهر والمراق الأيمن	للكتف الأيمن	الكتفين، على مسار الكولون
زمن الألم	نوبي متردد	بعد تناول الدسم بساعتين، بشكل نوبة	متناوب، متكرر، بعد الطعام

	التناذر القرحي	التناذر الصفراوي	التناذر الكولوني
محرضات الألم	الجوع، الطعام، NSAIDs، الشدة، الطعام الحر	الطعام الدسم بشكل رئيسي	الطعام، الشدّة والتوتر
مسكنات الألم	الطعام، مضادات الحموضة	مضادات التشنج، NSAIDs، نتجنب المورفين	الصيام، التغوط، الغازات،
الأعراض المرافقة	غثيان، إقياء، نزف هضمي	غثيان، إقياء، حمى، يرقان	إسهال، امساك، نزف
التشخيص	تنظير هضمي علوي	ECHO, ERCP, MRCP	فحص براز، تنظير هضمي سفلي

التشخيص التفريقي للتناذرات الهضمية:

التناذر القرحي	التناذر الصفراوي	التناذر الكولوني
• القرحة الهضميّة Peptic Ulcer Disease: عفجية "الأشيع" ومعدية. • التهابات المعدة Gastritis. • سرطان المعدة Gastric Cancer. • عسر الهضم.	• التهاب مرارة حاد Acute cholecystitis. • التهاب مرارة مزمن Chronic cholecystitis. • حصيات مرارة عرضية Gallstones. • التهاب طرق صفراوية صاعد.	• متلازمة الأمعاء الهيوجة Irritable Bowel Syndrome. • التهابات الكولون: جرثومية، فيروسية، مناعية. • أورام الكولون: Colon Cancer.

عند الانتهاء من الفحوص السريريّة ووصولنا لتشخيصات تفريقية تخص تناذر معين (تناذر قرحي أو صفراوي أو كولوني) نأتي للفحوص المتممّة لتأكيد تشخيصنا...

الفحوص المتممة

1. في حال وجدنا أن التناذر قرحي:

- نطلب **تنظير هضمي علوي**، فنتوجه إلى إحدى الحالات التالية:

قرحة معدية	قرحة عفجية	أحد التهابات المعدة

- في حال كان التنظير الهضمي العلوي **طبيعي**؛ فنتوجه إلى **عسرة الهضم Dyspepsia**.
- في حال وجود أعراض غير نموذجية، نقوم بإجراء فحوص متممة أخرى مثل الإيكوغرافي والـCT Scan.

2. في حال وجدنا أن التناذر صفراوي:

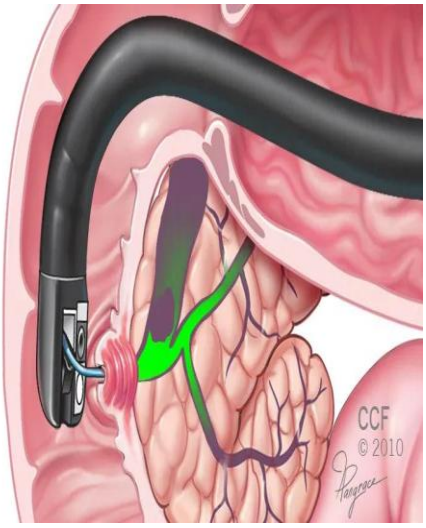
- نقوم بإجراء **إيكو بطن** لنتحرى المرارة والطرق الصفراويّة.
- قد تكون حصيّات مراريّة، أو تسمّك في جدار المرارة، يدل على التهاب مرارة حاد أو مزمن.
- توسّع في القناة الجامعة CBD، دليل على وجود حصاة فيها، وبالتالي يرشح المريض **لإجراء** *ERCP*.

تصوير الأقنية الصفراوية والبنكرياسية بالطريق الراجع (ERCP) Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography:

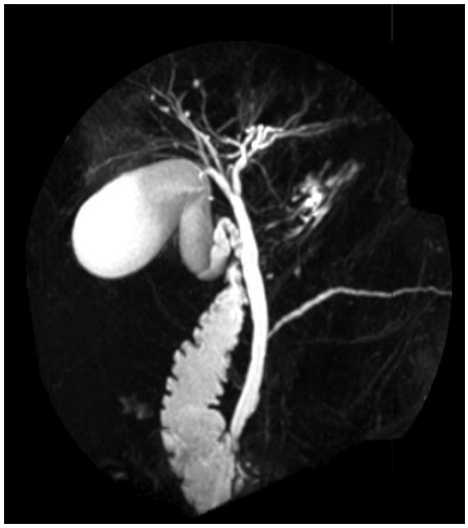
- تقوم هذه التقنية على مبدأ تصوير القناة الجامعة وبقية الأقنية الصفراوية والقناة البنكرياسية من خلال **إدخال قثطرة في حليمة فاتر** عبر المنظار وحقن المادة الظليلة.
- بعد تطور هذه الطريقة أصبحت تستخدم في المعالجة ايضا حيث يتم استئصال الحصيات الصفراوية السادة للقناة الجامعة بعد خزع حليمة فاتر **(إجراء تشخيصي وعلاجي)**.

تصوير الطرق الصفراوية والبنكرياسية بالرنين المغناطيسي (MRCP) Magnetic Resonance Cholangiopancreatography:

- تستخدم أحياناً بدلا من الـ ERCP **لغرض التشخيص** وليس العلاج إذ أنها أسهل للمريض.
- تمكننا هذه الطريقة من الحصول على رسم للشجرة الصفراوية والطرق البنكرياسية داخل وخارج الكبد **دون** الحاجة إلى إدخال منظار عبر المعدة.



ERCP



MRCP

3. في حال وجدنا أن تناذر كولوني:

- الفحوص المتممة المساعدة في التشخيص في هذه الحالة هي فحص البراز، التنظير الهضمي السفلي (الأهم).
- يفيد التنظير الهضمي السفلي بتشخيص أدواء الأمعاء الالتهابية (داء كرون، والتهاب الكولون القرحي) وأورام الكولون وأمراض الكولون الأخرى، وذلك من خلال التشخيص العياني أثناء إجراء التنظير بالإضافة إلى أخذ الخزعات ودراستها نسيجياً.
- في حال كان التنظير الهضمي السفلي **طبيعي**، نتوجه إلى الإصابة بمتلازمة الأمعاء الهيوجة IBS.

عند وجود مضاد استطباب للتنظير يمكن إجراء صورة ظليلة للكولونات أو رنين مغناطيسي MRI.

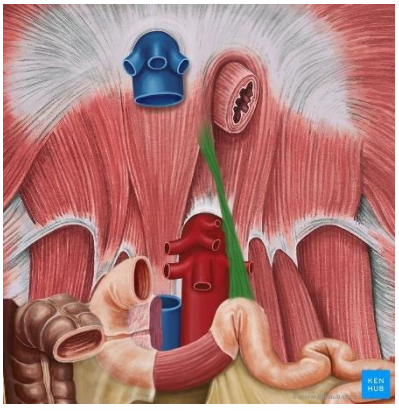
والآن بعد أن انتهينا من مقاربة الألم البطني، دعونا ننتقل إلى موضوع جديد ألا وهو النزف الهضمي...

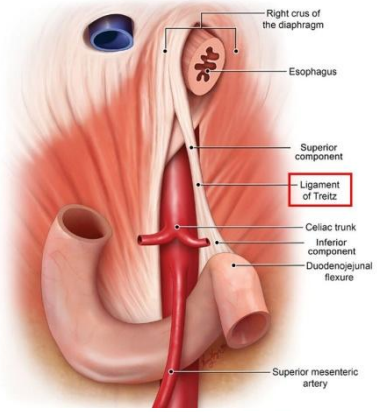
النزف الهضمي

- هو حدوث نزف في الأنبوب الهضمي بسبب تخريش الوعاء الدموي في الطبقة تحت المخاطية للأنبوب الهضمي، ويكون إما شريانياً (وعاء ضمن القرحة الهضمية)، أو وريدياً (دوالي المريء)، أو في الشعيرات دموية (نادراً) كالتهاب المعدي النزفي (السحجي).
- يخرج الدم من الأنبوب الهضمي عبر فتحتيه:
  - **فتحة الفم**: الإقياء الدموي Hematemesis، إقياء طحل القهوة.
  - **فتحة الشرج**: التغوط الزفتي Melena أو التغوط الدّموي Haematochezia.
- يقسم النزف الهضمي إلى نزف هضمي علوي ونزف هضمي سفلي؛ وذلك **حسب موقع النزف بالنسبة لرباط ترايتز**.

رباط ترايتز Ligament of treitz: RBO Clinical

- هو رباط ليفي يمتد **من السويقة الحجابية اليمنى إلى نهاية القطعة الرابعة من العفج** (الوصل العفجي الصائمي).
- إذا حصل النزف الهضمي أعلى رباط ترايتز هو نزف علوي، أما إذا حصل إلى الأسفل من هذا الرباط فهو نزف سفلي.





النزف الهضمي العلوي

☑ هو النزف الذي يحصل **أعلى رباط ترايتز**.

☑ يتظاهر النزف الهضمي العلوي على شكل: **إقياء دموي**[2]، **إقياء طحل قهوة**، **تغوط زفتي**، وفي حال كان غزير يمكن أن يتظاهر **كتغوط مدمى**.

ملاحظات عن التغوط الزفتي:

- 90% من حالات البراز الأسود (الزفتي) يدل على إصابة علوية فوق رباط ترايتز.
- 10% من حالات البراز الأسود يدل على نزف هضمي سفلي، كولون أيمن مثلاً أو بالأمعاء الدقيقة مع بطء مرور.
- قد يُعزى اللون الأسود للبراز إلى كون الشخص يتناول **أدوية معيّنة** (كالحديد أو البيزموت والكربون) أو **أطعمة** (مثل الشوندر والسبانخ والملوخية) لذلك يجب عدم إهمال سؤال المريض عنها.

التشخيص التفريقي للنزف الهضمي العلوي:

القرحة الهضمية Peptic Ulcer (عفجية أو معدية) أشيع الأسباب	التهاب مري قلسي	تمزق مالوري وايس	دوالي المريء والمعدة
أورام وسرطانات المعدة	التهابات المعدة الحادة التالية لأخذ أدوية أو تعاطي الكحول	تناول المميعات	التشوهات الوعائية

ما هو تمزُّق مالوري وايز؟ RBO Clinical

هو عبارة عن **تمزُّق طولاني في مخاطية الوصل المريئي المعدي**، ينتج عن الإقياء أو التهوع العنيف (نزف هضمي علوي غزير مع إقياء دموي عادةً)، وما يميزه سريرياً حدوث **إقياءات متكررة يتبعها بشكل فجائي إقياء دموي**.





[2] يجب تفريق الإقياء الدموي عن كل من النفث الدموي، اللعاب المدمى، والرعاف.

النزف الهضمي السفلي

☑ النزف الهضمي السفلي الحاد هو النزف الذي يحصل تحت رباط ترايتز (أي من الأمعاء الدقيقة أو الكولون أو الشرج).
☑ يتظاهر على شكل إما **تغوط مدمى**، أو **تغوط زفتي**.

↵ التغوط الزفتي في هذه الحالة يدل على إصابة في الأمعاء الدقيقة أو الكولونات (غالباً كولون أيمن) بشرط أن يترافق مع بطء مرور (إمساك).[3]

التشخيص التفريقي للنزف الهضمي السفلي:

1. أمراض الشرج:

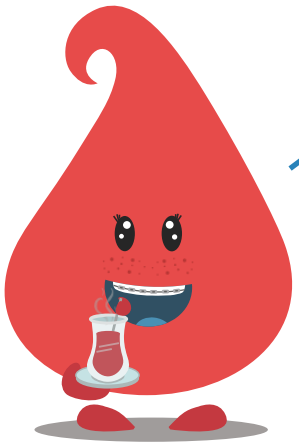
- بواسير - شق شرجي؛ وهنا يكون الدم تالياً للبراز وليس مخلوطاً معه (قطرات دم أحمر تغطي البراز السليم) ويترافق مع **ألم أثناء التغوط** مع **إمساك شديد**.

2. أورام الكولون والمستقيم:

- نزف **بدون ألم**، والدم مخلوط مع البراز ويترافق مع **إمساك حديث غالباً**، ويكون المريض متقدم في السن.

3. أسباب أخرى:

- **المرجلات (البوليبات):** وهي أورام سليمة معنقة أو لاطئة (غير معنقة)، والرتوج.
- **الأدواء المعوية الالتهابية IBD[4]:** التهاب الكولون التقرحي وداء كرون (يمكن أن تسبب إسهال مدمى مع زحير أحياناً).
- **التشوهات الوعائية:** خلل التنسج الوعائي angiodysplasia.



ليست بالأسباب ولن تكون!
هو الوهّاب يهب لمن يشاء، ما يشاء،
وقتما يشاء، وكيفما يشاء

[3] توضيح أربيسيزي للفهم: التغوط الزفتي يعني تغوط دم مهضوم، لذلك نجد أنه حتى يحدث في النزف الهضمي السفلي يجب أن يترافق مع إمساك (بينما يتم هضم الدم).

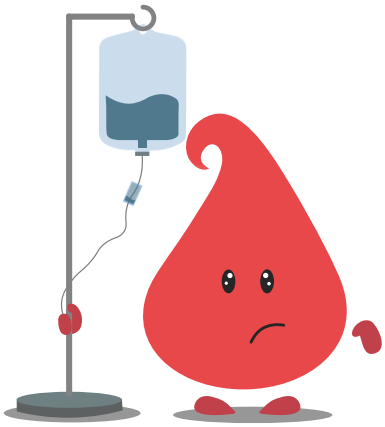
[4] Inflamatory Bowel Disease.

استجواب مريض النزف الهضمي

1. القصة السريرية:

- نسأل المريض عن **سوابقه المرضية:**
  - هل لديه قصة تناذر قرحي؟ (يتظاهر بآلام معدية شرسوفية).
  - هل لديه إصابة سابقة أدت إلى تشمع كبد مثل التهاب الكبد أو الكحولية؟ حيث أن الإصابات الكبدية تؤدي إلى ارتفاع توتر الوريد الباب، فتحدث دوالي مريء.
- نسأل المريض عن **سوابقه الدوائية:** هل يتناول أدوية مثل الأدوية التي تسبب القرحات المعدية؟
  - من الأدوية التي تسبب قرحات معدية **مضادات الالتهاب اللاستيروئيدية**؛ كالأسبرين والديكلوفيناك والبروفين، **مميعات الدم**؛ كالوارفارين، **الأدوية التي تغير لون البراز**.
- نسأل عن **نقص الوزن والشهية** حيث قد تشير للأورام.
- نسأل عن **تغيير عادات التغوط وطبيعته**.
  - في حال كان تغوط مدمى: نسأل عن صفات الدم؛ هل هو دم لوحده؟ أم الدم مخلوط مع البراز؟[5]
  - آلام أثناء التغوط: النزف الذي يترافق مع ألم إما شق شرجي أو بواسير، ونفكر بالشق الشرجي أكثر من الباسور لأن **الباسور غالباً ينزف دون ألم**.
- نسأل هل يشكو المريض من زحير؟

الزحير: هو شعور كاذب بالرغبة بالتغوّط، ويمكن أن يكون نتيجة وجود ورم في المستقيم (فالمستقيم لا يفرق بين الورم والبراز) فيرسل إشارات إلى الدماغ تحرض الشخص على دخول الحمام، هنا يجب السؤال عن قدم الحالة، فالحالات القديمة لاتدل على السرطان على عكس الحالات الحديثة.



[5] الدم لوحده الذي يتلو البراز (بضع نقاط تغطي البراز) هو غالباً إصابة شرج (شق شرجي – بواسير)، بينما الدم المخلوط مع البراز يكون غالباً من الجزء العلوي من الكولون كما ذكرنا سابقاً.

2. الفحص السريري:

- **الحالة العامة**: يجب تقييم حالة المريض في حال كان النبض متسرعاً مع تعرق ووهط دوراني والنزف صاعق، فالمريض دخل في صدمة نقص الحجم ويجب إسعافه بالسوائل.
- **شدة النزف**: يتم تقييم شدة النزف حسب:
  - الحالة العامة (علامات وهط دوراني مثل تعرق، برودة أطراف، دوار، إغماء).
  - العلامات الحيوية (الضغط، النبض، التنفس، الأكسجة).
  - التحاليل المخبرية (الخضاب لكن قد يكون طبيعي في البداية ، اختبارات التخثر مهمة عند مرضى الكبد أو تناول الوارفارين).
- **المس الشرجي**: مهم جداً.

3. الفحوص المتممة:

- قبل القيام بأي فحص علينا جعل حالة المريض مستقرّة من خلال تعويض الوريديّة ونقل الدم، ثم نبدأ بالاستقصاء لمعرفة سبب النزف.
- **أول الاستقصاءات** هو **التنظير الهضمي** (بنوعيه العلوي والسفلي) الذي **يعتبر علاجي وتشخيصي**، فنستخدمه لأخذ الخزع والتخثير والربط (في حال الدوالي حيث يمكن أن نربطها وفي حال القرحات نحقنها بمواد تقبض الأوعية مثل الأدرينالين).

لا نقوم بالتنظير السفلي قبل التأكد من سلامة السبيل الهضمي العلوي إلا إذا كانت العلامات تشير بشكل مؤكد الى إصابة الكولون.

- وأخيراً قد نضطر لاستقصاء الأمعاء الدقيقة في حال لم نستطع تحديد موقع وسبب النزف وذلك لأن آفاتها نادرة (إما بالمنظار الخاص بالأمعاء الدقيقة أو بالكبسولة).
- يمكن إجراء تصوير ظليل للأوعية الدموية في حال استمرار النزف دون اكتشاف الموقع.
- هناك 10٪ من الحالات مجهولة السبب وذلك بعد عمل كل الاستقصاءات.

النزف الهضمي الخفي

☑ يراجع المريض بأعراض فقر دم بعوز الحديد (وهن عام، شحوب، خفقان، زلة تنفسية).

- **الإناث في عمر النشاط التناسلي**: السبب الأول **اضطراب في الدورة الطمثية**.
- **الذكور بجميع الأعمار والإناث بعد سن الضهي**: السبب الأول هو **ضياع الدم عبر السبيل الهضمي**، وبالتالي البحث عن موقع وسبب النزف بإجراء تنظير هضمي علوي أولاً، ثم سفلي.....

☑ يمكن إجراء فحص الدم الخفي في البراز OBT.

دوّن ملاحظاتك